

例 10-4 图 10-1 显示 3 种不同膀胱灌注化疗方法治疗后膀胱癌的再发率资料。可见，不同灌注化疗方法是相互独立的不连续指标，因此可用直条图进行描述。该图只按灌注化疗方法分类，为单式立式直条图。

例 10-5 图 10-2 显示某地 2005 年和 2010 年小学生男女患龋率的资料。性别是相互独立的指标，但相比单式条图，本例中将不同年份的龋齿率的直条按男、女分别绘出，可用以比较不同性别在不同年份的龋齿率的大小。

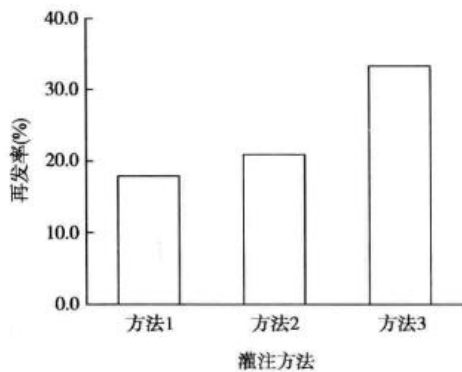


图 10-1 某年某医院不同膀胱灌注化疗后膀胱癌再发率(%)

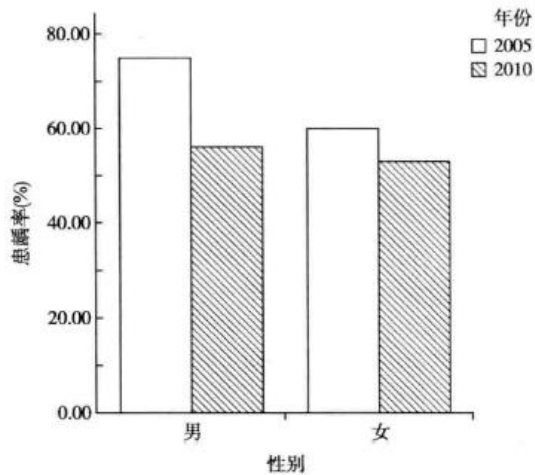


图 10-2 某地 2005 年和 2010 年小学生男女患龋率(%)

例 10-6 某年某医院对 327 例初次行人工髋关节置换术失败的案例进行分析，根据失败原因构成资料绘制成图 10-3。从图可见假体无菌性松动是置换术失败的首要原因，与感染、假体周围骨折 3 种原因共占失败案例的 92%，是人工髋关节置换术失败的主要原因。

另外，百分比条图特别适合作多个构成比的比较，将不同组别、不同时间或不同地区的某分类指标的构成比平行地绘制成多个百分比条图，可以方便地比较其构成比的差异。

例 10-7 根据 1996 和 2000 年全国 5 岁以下儿童前五位病种死亡构成比(%)资料绘制成图 10-4，由百分比条图可见，与 1996 年相比 2000 年的肺炎导致的死亡构成比减少，早产导致的死亡构成比增加。

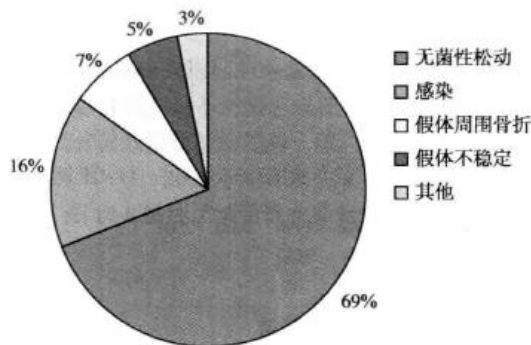


图 10-3 某年某医院 327 例初次行人工髋关节置换术失败原因构成(%)

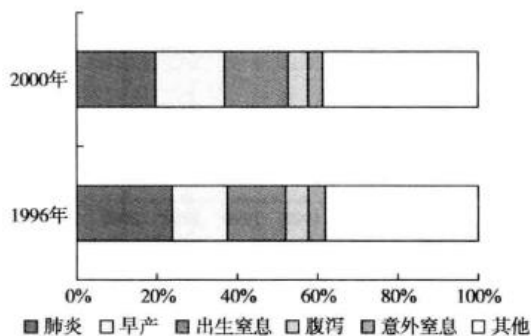


图 10-4 1996 年和 2000 年全国 5 岁以下儿童主要病种死亡构成比较

例 10-8 图 10-5 是根据 2006—2010 年某地男女

布氏菌病发病人数资料绘制的普通线图, 该图用于描述和比较不同性别布氏菌病发病人数随年份变化的趋势。

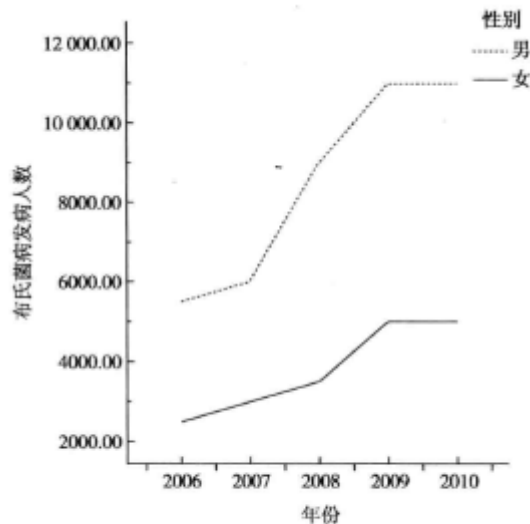


图 10-5 2006—2010 年某地男女布氏菌病发病人数趋势比较

例 10-9 调查某地 1997—2001 年艾滋病和梅毒两种与性传播有关疾病的发病率, 资料分别绘制成普通线图(图 10-6a)和半对数线图(图 10-6b)。普通线图显示梅毒的增长幅度较大, 但半对数线图则显示艾滋病的增长速度更快。

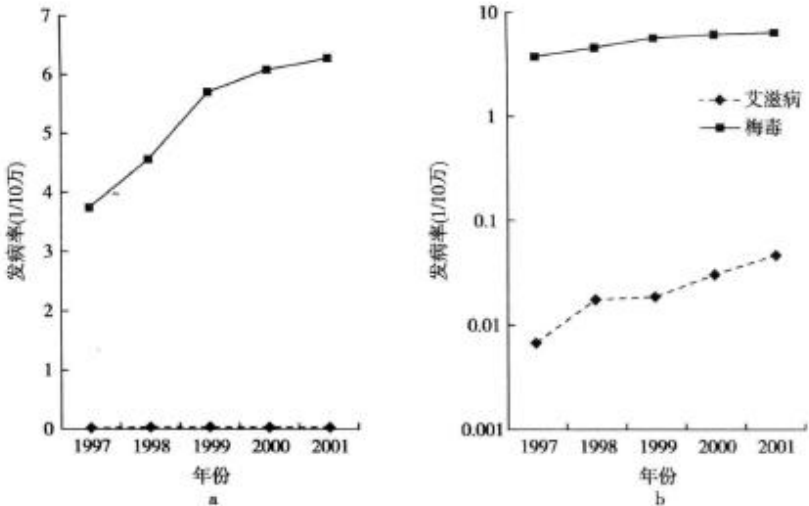


图 10-6 某地 1997—2001 年艾滋病和梅毒发病率的变化趋势
a. 纵轴为算术尺度; b. 纵轴为对数尺度

例 10-10 某年某地共报告乙型病毒性脑炎 104 例, 其年龄分布如表 10-6, 绘制的直方图见图 10-7。

表 10-6 某年某地乙型病毒性脑炎病例的年龄分布

年龄(岁)	病例数	每岁病例数	年龄(岁)	病例数	每岁病例数
0	7	7.0	8	3	3.0
1	15	15.0	9	2	2.0
2	8	8.0	10~	8	1.6
3	11	11.0	15~	3	0.6
4	14	14.0	20~	1	0.2
5	14	14.0	25~	2	0.4
6	8	8.0	30~	1	0.2
7	6	6.0	35~40	1	0.2

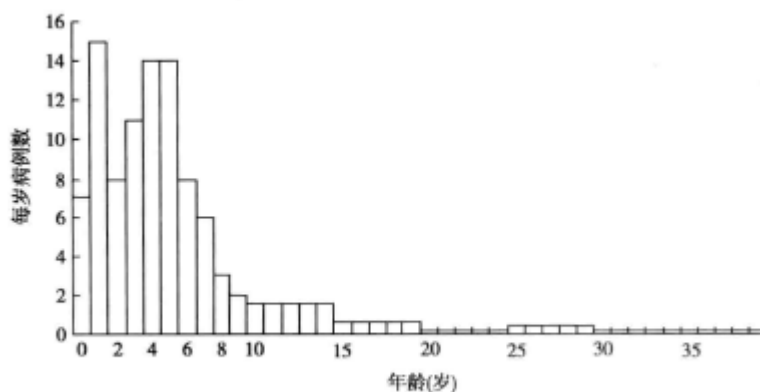


图 10-7 某年某地乙型病毒性脑炎病例的年龄分布

例 10-13 利用第二章例 2-1 的数据绘制茎叶图, 结果为图 10-10。图中茎的宽度为 1, 即观察值的整数位。每个叶代表 1 个观察值, 显示的尾数即观察值的第一位小数。从图可以看出成年女子的红细胞数 ($\times 10^{12}/L$) 的分布范围约从 3.1~5.5, 基本近似正态分布。并且可以查看每个观察值的取值情况。

[illegible]

图 10-10 138 名成年女子的红细胞数($\times 10^{12}/L$)茎叶图

例 10-14 利用第四章例 4-2 的数据绘制误差条图, 从图 10-11 可见安慰剂组的低密度脂蛋白均数高于所有不同剂量的新药组, 而大剂量新药组的低密度脂蛋白均数低于低剂量组和中剂量组, 差异有统计学意义。

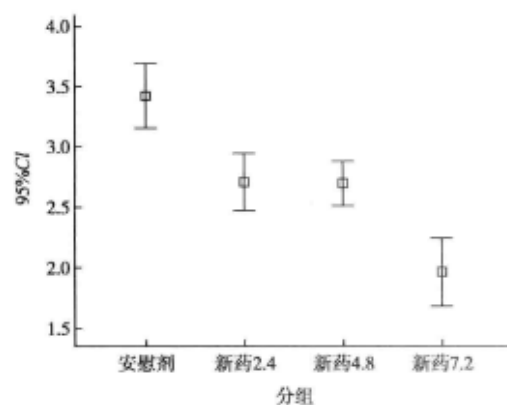


图 10-11 4 个处理组低密度脂蛋白的均数与 95% 可信区间